

TEMA 58



LA SALUD MENTAL.

ASPECTOS SOCIALES Y LEGALES A TENER EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Aspectos sociales en la intervención con personas con problemas de salud mental.	
2.- Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.	
2.1.- Definición y objetivos. 2.2.- Tipología de recursos.	
3.- Aspectos legales en la intervención con personas con problemas de salud mental.	
3.1.- Conceptos básicos. 3.2.- Aspectos legales en el ámbito penal. 3.3.- El internamiento involuntario.	

TRUJILLO FORMACIÓN

O.- INTRODUCCIÓN.

Los servicios públicos de salud constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades», de tal forma que la salud mental es parte integral de la salud y el bienestar de las personas.

La salud mental se reconoce como un **proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos**, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.

La salud mental de la población se halla especialmente condicionada por **determinantes sociales y económicos**. Existe evidencia empírica de que las situaciones de desempleo y precariedad laboral son factores que incrementan el riesgo de padecer problemas de salud mental.

Asimismo, el estrés laboral, la desigualdad de género, las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la ausencia de tiempo de ocio, la aceleración del ritmo de vida, la falta de contacto con la naturaleza o la pérdida de vínculos sociales y comunitarios, entre otros determinantes, son causas o riesgos asociados a la proliferación de problemas de salud mental.

Otros factores culturales, como la difusión de discursos individualistas que ponen el foco en la autoexigencia y en la hiperresponsabilización individual, obviando las causas y estructuras sociales, contribuyen a perfilar una sociedad del cansancio en la que las personas tornan en empresarias de sí mismas, como han diagnosticado algunos filósofos contemporáneos. Se configura así un contexto de malestar social que favorece la prevalencia de problemas de salud mental.

Según la **Encuesta Europea de Salud en España 2020**, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país el 12,74 % de la población de 15 y más años presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad, siendo la frecuencia de la sintomatología depresiva prácticamente el doble en mujeres que en hombres. Según datos del INE para el primer trimestre de 2020, el suicidio se ha mostrado como la primera causa de muerte externa en la población española. Aunque actualmente no contamos con datos contrastados por organismos oficiales, se estima que la tasa de suicidios se ha incrementado debido a los problemas de salud mental derivados de la pandemia.

La salud mental, como la salud en general, debe ser promovida con **políticas públicas integrales que erradiquen la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales y garanticen los derechos sociales y laborales**. Sin perjuicio de lo anterior, los poderes públicos también tienen el deber de implementar las actuaciones necesarias para avanzar en la prevención, promoción y atención a la salud mental.

Pero no solo se trata de atenuar los perjuicios de los problemas de salud mental, sino también de eliminar los prejuicios asociados a ellos. Por ende, la presente ley enfatiza tanto la dimensión asistencial como la dimensión promocional para **poner fin a la estigmatización y la discriminación de las personas que padecen problemas de salud mental.**

TRUJILLO FORMACIÓN

La salud mental se define por la **OMS** como «**un estado de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad**». En el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, la OMS constató a nivel global la insuficiencia de recursos para ofrecer una respuesta adecuada en materia de salud mental y propuso los siguientes objetivos: reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en materia de la salud mental; proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta; poner en práctica estrategias de promoción y prevención; y fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental.

En **2005**, la **OMS** organiza una **Conferencia en la Región Europea** en la que España y otros 51 países aprueban la Declaración Europea de Salud Mental, que determina las siguientes prioridades: concienciar de la importancia del bienestar mental; rechazar colectivamente los estigmas, la discriminación y la desigualdad de las personas con problemas de salud mental; desarrollar sistemas de salud mental integrales, integrados y eficientes; contar con profesionales competentes en la materia; y reconocer la experiencia y el conocimiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental y sus cuidadores.

La OMS también ha recordado en varias ocasiones que las personas con problemas mentales suelen vivir situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la sociedad y que estas situaciones contravienen el acuerdo ratificado por distintos países en **la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad**, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que en nuestro país se encuentra en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Desde entonces, se acepta que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades y que hay que proteger los derechos y la dignidad de las personas con diversidad funcional, así como su participación en la vida civil, política, económica, social y cultural de sus países.

En el año 2006, la Convención ya mentada de la Organización de las Naciones Unidas modifica el concepto de «discapacidad» de una visión tradicional de la misma como un concepto estático para proclamar que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, en la discapacidad intervienen dos factores: i) número y carácter de las barreras existentes en el entorno de la persona y ii) número y carácter de los apoyos existentes en el entorno de la persona.

Las personas con **enfermedades mentales graves y duraderas** (esquizofrenias, trastornos maniacodepresivos, trastornos depresivos graves, trastornos paranoides y otras psicosis) sufren un conjunto de problemáticas y necesidades que desbordan el ámbito sanitario-psiquiátrico, presentando importantes **dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo y en su integración social y laboral normalizada**.

Por ello la adecuada atención comunitaria a estas personas exige la participación e implicación del sistema de Servicios Sociales colaborando y complementando al sistema sanitario de salud mental, tal como se indica en la Ley General de Sanidad de abril de 1986 en su artículo 20, apartado 3.

La Comunidad de Madrid desde 1988 desarrollo el **Programa de Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica**, dependiente entonces de la antigua Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Dicho Programa tenía como objetivo atender las necesidades sociales específicas de las personas con enfermedades mentales crónicas. Para ello, había puesto en marcha un conjunto de **equipamientos de servicios sociales especializados de rehabilitación psicosocial, rehabilitación laboral, atención residencial y soporte comunitario orientados a favorecer y apoyar la integración social de dichas personas, trabajando de un modo complementario y coordinado con la red de servicios sanitarios de salud mental**.

TRUJILLO FORMACIÓN

El término Paciente o Enfermo Mental Crónico es utilizado para definir un extenso y difuso grupo de pacientes que sufren una enfermedad mental grave de larga duración. El término «enfermo mental crónico» (EMC) o personas con "Trastornos mentales severos"(TMS) viene a delimitar a un grupo de población variado y heterogéneo.

De todos modos, hay un consenso cada vez mayor en definir las principales características de este colectivo. Así se entiende por **población enferma mental crónica**, aquella que incluye a:

«Personas que sufren ciertos trastornos psiquiátricos graves y crónicos como: esquizofrenia, trastornos maniaco-depresivos y depresivos graves recurrentes, síndromes cerebro- orgánicos, trastornos paranoides y otras psicosis, así como algunos trastornos graves de la personalidad, que dificultan o impiden el desarrollo de sus capacidades funcionales en relación a aspectos de la vida diaria, tales como: higiene personal, autocuidado, autocontrol, relaciones interpersonales, interacciones sociales, aprendizaje, actividades recreativas y de ocio, trabajo, etc.; y que además dificultan el desarrollo de su autosuficiencia económica. Así mismo muchas de estas personas han estado hospitalizadas en algún momento de sus vidas, variando su duración según los casos» (Goldman, Gatozzi y Tanbe, 1981).

Con el fin de intentar evitar las connotaciones negativas y estigmatizantes del término "crónico o cronicidad", últimamente en la literatura especializada se viene utilizando en vez del "enfermo mental crónico", el término **trastorno mental severo** (TMS) para referirse a los trastornos mentales graves de duración prolongada y que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social.

1.- ASPECTOS SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

Quizás la definición más representativa y que ha alcanzado un mayor consenso sea la que emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU. en 1987, y que incluye **tres dimensiones**:

1.- **Diagnóstico:** Incluye a los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y algunos trastornos de la personalidad.

2.- **Duración de la enfermedad y del tratamiento:** Tiempo superior a los dos años.

3.- **Presencia de Discapacidad**: Originalmente se determinó por la presencia de al menos tres de los ocho criterios que especificaba el NIMH, pero que posteriormente se sustituyeron por la existencia de una disfunción moderada o severa del funcionamiento global, que indica una afectación de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar.

Las necesidades y problemáticas son, por tanto, múltiples y variadas. Como personas y ciudadanos que son, antes que enfermos mentales, comparten con el resto de la población **problemáticas y necesidades comunes** (alimentación, higiene, salud, alojamiento, seguridad, convivencia, afecto, sexualidad, apoyo social y familiar, trabajo, etc.). Y además presentan **dificultades y necesidades específicas** vinculadas a la problemática psiquiátrica y psicosocial peculiar de este colectivo. Entre ellas se podrían indicar las siguientes:

TRUJILLO FORMACIÓN

Atención y tratamiento en salud mental.	Los pacientes con enfermedades mentales graves y crónicas necesitan adecuados procesos de diagnóstico y tratamiento psiquiátrico (fundamentalmente psicofarmacológico) que permitan controlar su sintomatología psicopatológica, prevenir la aparición de crisis y en su caso controlarlas, así como mejorar su funcionamiento psicológico.
Atención en crisis.	Incluso los pacientes que están recibiendo un adecuado tratamiento psiquiátrico, pue- den experimentar crisis periódicas. La atención en crisis, a través en muchos casos de la hospitalización breve, deberá ayudar al paciente a estabilizar y reajustar su situación psicopatológica y a posibilitar la recuperación de su nivel de funcionamiento.
Rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración social.	Como se ha indicado, a pesar de la mejoría y control de la sintomatología psiquiátrica que se derivan de los tratamientos farmacológicos y otras terapias en la atención de salud mental, muchos de las personas que sufren esquizofrenia u otras psicosis presentan variados déficit y discapacidades que dificultan su desenvolvimiento autónomo y su integración en la vida cotidiana comunitaria. Por ello necesitan programas y servicios de rehabilitación psicosocial que les ayuden a recuperar y/o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para vivir y relacionarse en la comunidad; y que les apoyen de un modo flexible y continuado para favorecer su integración social efectiva en sus entornos sociales y familiares.
Rehabilitación laboral y apoyo a la integración laboral.	La integración laboral es un componente clave para facilitar la autonomía, independencia e integración social de cualquier persona. Sin embargo, la mayoría de los enfermos mentales crónicos en general y de los pacientes con esquizofrenia en especial, están desemplea- dos o excluidos del mundo laboral y presentan importantes dificultades para acceder y mantenerse en puestos de trabajo competitivos. Necesitan, por tanto, programas de rehabilitación laboral que les orienten y ayuden a adquirir aquellos hábitos laborales y habilidades que les permitan estar en mejores condiciones para acceder y manejarse en el mundo laboral. También necesitan mejorar su, en general escasa, cualificación profesional a través de programas adaptados de formación ocupacional. Asimismo, dadas las exigencias y barreras del mercado laboral, serán necesarias acciones y medidas que potencien la incorporación de este colectivo en el mundo laboral, tanto a través del fomento de la creación de empresas en las que se puedan integrar enfermos mentales, como apoyando específicamente la contratación de dichas personas en el mercado laboral ordinario.
Alojamiento y atención residencial comunitaria.	Muchos pacientes tienen dificultades para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y cuidado. Algunos que no cuentan con apoyo familiar pueden verse incluso abocados, en determinadas circunstancias, a situaciones de riesgo y marginación. Ante esto, es necesario contar con un abanico de alternativas de vivienda y atención residencial, que cubran sus diferentes necesidades de alojamiento, cuidado y supervisión, permitiendo su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones de autonomía y calidad de vida posibles. Esta es una necesidad fundamental en la atención comunitaria de esta población, su inadecuada cobertura contribuye a generar un conjunto de consecuencias negativas, entre otras: • Incremento del fenómeno de la puerta giratoria, al aumentar los reingresos

TRUJILLO FORMACIÓN

	hospitalarios. • Uso inadecuado de la atención hospitalaria. • Dificultad para la desinstitucionalización de los pacientes que permanecen internados. • Aumento del riesgo de situaciones de marginación sin hogar. • Sobrecarga de algunas familias, que se pueden "quemar" y desestructurar al verse sobrepasadas por el cuidado y convivencia con su familiar enfermo mental crónico.
Apoyo económico.	De igual modo, muchos pacientes tienen dificultades para alcanzar una mínima autosuficiencia económica, debido a su escasa o esporádica historia laboral y a sus dificultades para acceder y mantenerse en un puesto de trabajo. Se hace, pues, necesario, ayudarles a cubrir sus necesidades económicas mínimas cuando no cuentan con otros ingresos ni tienen apoyo económico de sus familias, tanto para evitar situaciones de pobreza como para facilitar su autonomía y manejo en el entorno social. Ello implica apoyar a estas personas para que se puedan beneficiar de los sistemas de prestaciones económicas existentes tanto contributivas como no contributivas. Asimismo, es necesario disponer para aquellas personas que no puedan acceder a dichas prestaciones, de programas de apoyo con fondos que permitan proporcionar ayudas económicas individualizadas que sirvan para facilitar procesos de rehabilitación y mantenimiento autónomo en la comunidad.
Protección y defensa de sus derechos.	La problemática psiquiátrica y psicosocial de las personas enfermas mentales crónicas en general y de los pacientes con esquizofrenia en especial, así como las barreras y desventajas sociales que sufren, hacen de esta población un grupo especialmente indefenso y vulnerable ante posibles abusos, situaciones de desprotección y obstáculos para el pleno acceso y ejercicio de sus derechos civiles como ciudadanos de pleno derecho. Por ello es preciso asegurar y promover la defensa y protección de sus derechos tanto en dispositivos de atención y tratamiento como en la vida cotidiana.
Apoyo a las familias.	Las familias constituyen el principal recurso de cuidado y soporte comunitario de los enfermos con esquizofrenia. De hecho, la gran mayoría viven con sus familias. Sin embargo, la convivencia con el paciente puede suponer dificultades y conflictos, que en ocasiones puede llevar a las familias a sentirse desbordadas y con escasos recursos para hacer frente a dichos problemas. Asimismo, en algunos casos esta situación puede degenerar en una importante tensión y sobrecarga para las familias. En función de lo anterior, las familias deben ser apoyadas y cuidadas (es necesario «cui- dar a los que cuidan»), necesitan información, educación, asesoramiento y apoyo para entender la problemática de su familiar enfermo mental crónico y contar con estrategias y recursos para manejar y mejorar la convivencia y para ser agentes activos de la rehabilitación de su familiar enfermo mental crónico. Asimismo, necesitan ayuda y apoyo para mejorar la calidad de vida de la propia familia. Este conjunto de problemáticas y de necesidades específicas de este colectivo de personas enfermas mentales crónicas, debe de ser tenido en cuenta en su globalidad a la hora de ofrecer una adecuada atención a este colectivo.

TRUJILLO FORMACIÓN

	La organización y articulación de una adecuada y comprehensiva red de atención comunitaria que permita el mantenimiento e integración en la sociedad de la población con enfermedades psiquiátricas graves crónicas, constituye uno de los retos más desafiantes e interesantes a los que se enfrentan los profesionales y los sistemas de servicios sanitarios y sociales.

2.- RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA.

A partir de la **Reforma Psiquiátrica** se ha transformado la atención a la población con enfermedad mental, pasando de un modelo institucionalizador a un **modelo comunitario.** La problemática de las personas con trastornos mentales severos y persistentes no es solo sanitaria, sino eminentemente social, ya que genera falta de autonomía personal y social, aislamiento, dificultades de inserción laboral, problemas familiares, etc. La organización de una adecuada atención comunitaria a esta población requiere la actuación coordinada y complementaria de los Servicios Sanitarios de **Salud Mental** y de los **Servicios Sociales**, tanto en la Atención Social Primaria, como en la Atención Social Especializada.

La Comunidad de Madrid ha aprobado el **Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, 2.022-2.024.** En dicho Plan se hace referencia a la atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera. La Red pública de atención social a personas con enfermedad mental cuenta con diferentes tipos de centros y recursos de atención social especializada que ofrecen, en régimen de atención diurna (centros de rehabilitación psicosocial, centros de día de soporte social, centros de rehabilitación laboral) y de atención residencial (residencias, pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones), distintos programas y actividades para atender las distintas necesidades sociales de estas personas.

Asimismo, cuenta con servicios complementarios, como los equipos de apoyo social comunitario para ofrecer atención social en el propio domicilio y en el entorno a las personas con mayores dificultades sociales a fin de mejorar su calidad de vida, su mantenimiento en la comunidad y su vinculación a la red de atención.

También se desarrollan programas y recursos específicos de apoyo a la reinserción social de personas sin hogar con enfermedad mental grave.

Esta Red de Atención social trabaja en **estrecha coordinación y complementariedad con la red sanitaria de servicios de Salud Mental** para asegurar una atención socio-sanitaría integral a las personas con trastorno mental grave. Desde los Servicios de Salud Mental se ofrece el diagnóstico, tratamiento y seguimiento psiquiátrico que las personas con trastorno mental grave necesitan y en el marco de los **programas de continuidad de cuidados** (PCC) de dichos SSM, como eje de coordinación y seguimiento del itinerario individualizado de atención, se valoran las problemática y necesidades de atención social y apoyo a la rehabilitación e integración que tienen y se les deriva a los centros y recursos de atención social que necesiten de la Red de Atención social a personas con enfermedad mental. Así pues, la coordinación socio-sanitaria y la complementariedad con la red sanitaria de salud mental es un principio rector y un criterio básico de organización y funcionamiento de la Red de Atención social a personas con enfermedad mental.

Esta Red está conformada pues por una amplia y diversificada tipología de centros y recursos sociales específicos y especializados y que se distribuyen territorialmente de forma equilibrada en las diferentes

TRUJILLO FORMACIÓN

zonas de la Comunidad de Madrid. La citada Red cuenta actualmente con un total de 6.854 plazas en 233 centros y servicios de atención social especializada en las distintas zonas y municipios de la Comunidad Madrid y en la que trabajan unos 1530 profesionales.

En este nuevo Plan de Salud Mental se viene a consolidar y potenciar esta línea de trabajo coordinado y complementario entre ambas redes (Red sanitaria de Salud mental de la Consejería de Sanidad y la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera) para asegurar una adecuada atención integral a las necesidades de las personas con trastorno mental grave y apoyar su rehabilitación, recuperación e integración social.

Por ello se plantea como objetivos seguir trabajando juntos para asegurar una coordinación eficaz y fluida entre ambas redes sanitaria y social en la atención al trastorno mental grave, identificar necesidades desde ambas redes para mejorar la atención al TMG y consolidar una atención sociosanitaria integral al TMG.

2.1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

Es una red pública que agrupa a distintos tipos de centros y recursos de atención social, desde el nivel de la Atención Social Especializada, cuya principal misión es **atender las necesidades psicosociales y sociales, y promover la rehabilitación e integración social de las personas con enfermedades mentales severas y apoyar a sus familias.**

Sus **objetivos generales** son:

- Favorecer que dichas personas se mantengan en la comunidad en mejores condiciones de normalización, integración y calidad de vida.
- Posibilitar que puedan funcionar y desenvolverse en la comunidad del modo más autónomo posible.
- Potenciar su integración social.
- Evitar procesos de marginación y/o institucionalización.
- Apoyar a las familias mejorando sus capacidades y recursos y promoviendo la mejora en su calidad de vida.

En la actualidad estás competencias son asumidas desde la **Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad** de la **Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.**

La valoración y el reconocimiento de la situación de dependencia no es un requisito necesario para acceder a los distintos centros y servicios de la red de atención social a personas con enfermedad mental. **El modo de acceder a estos centros y servicios es siempre a través de la derivación desde los Servicios de Salud Mental de la red sanitaria pública** responsables del tratamiento y seguimiento psiquiátrico de las personas que padecen un trastorno mental grave.

Si una persona con trastorno mental grave tiene reconocida la situación de dependencia en relación a su enfermedad mental, su Programa Individual de Atención (PIA) podrá establecer que sea atendida en el marco

TRUJILLO FORMACIÓN

de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, pero será siempre el Servicio de Salud Mental responsable de su tratamiento el que deberá valorar cuál es el centro o servicio de esta red más idóneo y, en cada caso, proceder a su derivación de acuerdo a los mecanismos de coordinación establecidos en cada zona entre los Servicios de Salud Mental y los centros y servicios de la red de atención social a personas con enfermedad mental.

Esta Red pública de atención social especializada se dirige a las personas de la Comunidad de Madrid que sufren **enfermedades mentales graves y duraderas** (esquizofrenia, trastornos maniaco-depresivos, trastornos depresivos graves y recurrentes, trastornos paranoides y otras psicosis) y que tienen discapacidades y dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración comunitaria que hacen necesario el apoyo desde alguno de los recursos de atención social de dicha red. Así mismo se dirige a ofrecer el **apoyo a las familias que conviven y cuidan de un enfermo mental crónico.**

2.2.- TIPOLOGÍA DE RECURSOS.

Esta Red cuenta con una a**mplia y diversificada tipología de centros y recursos sociales específicos** que están en funcionamiento en las diferentes áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, compuesta por:

Centros de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S.)
Ofrecen programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración y actividades de apoyo social, para ayudar a las personas con enfermedad mental severa y persistente a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social, mejorar su funcionamiento psicosocial y promover su mantenimiento e integración en la comunidad. Así mismo ofrecen psicoeducación, asesoramiento y apoyo a las familias.
Centros de Día de soporte social (C.D.)
Ofrecen programas y actividades de apoyo y soporte social, para ayudar a las personas con enfermedad mental severa y persistente con mayores niveles de dificultades de funcionamiento, aislamiento y dependencia, a alcanzar un mínimo de autonomía y apoyar su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles.
Centros de Rehabilitación Laboral (C.R.L.)
Ofrecen programas de rehabilitación laboral para ayudar a aquellas personas con enfermedad mental que han alcanzado un buen nivel de autonomía, a aprender o recuperar los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su integración y mantenimiento en el mismo.
Alternativas Residenciales Comunitarias
Residencias (R): Servicio residencial flexible y polivalente de entre 20 y 30 plazas. Ofrece estancias cortas, transitorias o indefinidas para atender diferentes necesidades. Así como atención psicosocial, apoyo rehabilitador y supervisión las 24 horas del día. **Pisos supervisados (PS):** Alternativa de alojamiento estable y normalizada organizada en pisos normales en los que residen 3 ó 4 personas con enfermedad mental recibiendo el apoyo y supervisión que en cada momento necesiten. **Plazas supervisadas en Pensiones (PC):** A través del concierto de plazas en Pensiones se pretende ofrecer un alojamiento digno y la cobertura de necesidades básicas de personas con enfermedad mental con un

TRUJILLO FORMACIÓN

buen nivel de autonomía, pero sin apoyo familiar ni recursos económicos intentado evitar procesos de marginación.

Otros Recursos.

Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC): Como una nueva iniciativa que viene a completar la red de centros se han desarrollado los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) que funcionan de un modo integrado y coordinado con los programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental de cada Distrito, y que permiten ofrecer atención social domiciliaria y en el propio entorno a aquellas personas con enfermedad mental severa con dificultades y necesidad de apoyo social para poder mantenerse en su entorno familiar y comunitario, siendo por tanto un recurso más de la red de Atención Social, que da cobertura social y apoyo domiciliario y comunitario a las personas con patología grave atendidas en los Programas de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de los diferentes Servicios de Salud Mental de distrito.

Servicio de Atención Social y apoyo a la reinserción Social de enfermos mentales crónicos sin hogar: Se trata de una iniciativa específica dirigida a aquellos con enfermedad mental que se encuentran en una situación de marginación sin hogar. Por una parte, se dirige a los enfermos mentales atendidos en el Centro de Acogida Municipal San Isidro ofreciendo programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario. Asimismo, cuenta con varios pisos supervisados para facilitar su proceso de reinserción social. También ofrece apoyo social, acompañamiento y procesos de reinserción con aquellos enfermos mentales en situación de grave marginación sin hogar que se encuentran en las calles o en contactos con recursos básicos de la red de atención a personas sin hogar, trabajando para ello en estrecha coordinación y complementariedad con el equipo sanitario de atención psiquiátrica de calle dependiente de Salud Mental y con la red de recursos de atención a personas Sin hogar del Ayuntamiento de Madrid y de otras entidades sociales.

DERIVACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS.

El único canal de acceso a los diferentes centros y recursos dependientes de la Red pública de Atención social a personas con enfermedad mental, es **a través de la derivación desde los Servicios de Salud Mental de distrito** que atiendan a la persona con enfermedad mental.

Los centros y recursos de esta Red están sectorizados en las diferentes áreas y distritos sanitarios y trabajan en estrecha coordinación y complementariedad con los Servicios de Salud Mental como responsables del tratamiento, atención y seguimiento de las personas con enfermedad mental severa y persistente. Asimismo, para favorecer la integración, la red de recursos trabaja también **en colaboración y coordinación con los Servicios Sociales Generales y otros recursos comunitarios de cada zona**.

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSICAL (CRPS).

TRUJILLO FORMACIÓN

¿Qué son los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)?

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) son un tipo de Centros de Día de atención psicosocial especializada destinados a las personas con enfermedades mentales severas para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social y promover su mantenimiento e integración en la comunidad. Así como apoyar y asesorar a sus familias.

Su capacidad de atención se sitúa entre 60 usuarios y un máximo de 90.

Los CRPS trabajan en estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental encargados de la atención psiquiátrica y seguimiento de estas personas, así como con los Servicios Sociales Generales y con los recursos sociocomunitarios normalizados para favorecer la integración de los usuarios atendidos.

¿A qué población se dirigen los CRPS?

A las personas con enfermedades mentales graves y persistentes (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos paranoides, otras psicosis, etc.) que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo y en su integración social normalizada y necesitan una apoyo específico y estructurado para avanzar en su rehabilitación e integración en la comunidad.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de habilidades y competencias personales y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de autonomía, normalización y calidad de vida.

- Potenciar y apoyar su integración social facilitando el desempeño de roles sociales valiosos y normalizados.

- Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que cada persona necesite para asegurar su mantenimiento en la comunidad del modo más autónomo y normalizado que sea posible en cada caso.

- Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.

- Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia, Servicios Sociales Generales y otros recursos sociocomunitarios para favorecer y articular una atención integral que posibilite procesos de rehabilitación y apoyo comunitario ajustados a las necesidades de cada usuario.

¿Qué Actividades realizan los CRPS?

Programas individualizados de Rehabilitación Psicosocial y apoyo a la Integración Social.

Se ofrecen diferentes actividades de entrenamiento y recuperación de habilidades y capacidades para ayudar a estas personas a mejorar su autonomía y nivel de funcionamiento en las distintas áreas de la vida personal y social. Orientándose siempre a favorecer y apoyar su integración en su entorno comunitario, potenciado el desempeño de roles sociales normalizados. Para ello se trabaja entre otras cosas, apoyando el uso de recursos sociocomunitarios y el desarrollo de redes sociales de apoyo.

Las principales áreas de intervención psicosocial y social son las siguientes:

- **Autocuidado** (aseo e higiene personal, vestido, hábitos saludables), **psicomotricidad**.
- **Actividades de la vida diaria** (manejo de la vivienda, hábitos domésticos, manejo social, uso de transportes, realización de tramites, manejo del dinero, etc.), **psicoeducación** (conocimiento y manejo de la enfermedad, adherencia al tratamiento, autoadministración de la medicación, factores de riesgo, prevención de recaídas, etc.), **autocontrol y manejo del estrés, habilidades sociales, déficit cognitivos, ocio y tiempo libre.**
- **Integración comunitaria** (uso de recursos sociocomunitarios, promoción y desarrollo de redes sociales, etc).
- **Orientación y apoyo a la inserción laboral, apoyo a la integración social y soporte**

TRUJILLO FORMACIÓN

comunitario. y seguimiento en la comunidad

Seguimiento y apoyo comunitario. Una vez finalizado el proceso específico de rehabilitación y/o alcanzados los principales objetivos establecidos en el plan individualizado de cada usuario, los CRPS desarrollarán un proceso flexible de seguimiento y apoyo comunitario que asegure el mantenimiento del nivel de funcionamiento e integración alcanzado, con especial énfasis en aquellos usuarios con mayores dificultades o dependencia ofreciéndoles el apoyo necesario a través de actividades de soporte social en el propio centro y en el entorno comunitario. Este seguimiento, apoyo comunitario y soporte se desarrollará desde los CRPS trabajando en estrecha colaboración con los Servicios de Salud Mental de referencia y con los Servicios Sociales generales, así como optimizando el uso de recursos sociocomunitarios normalizados. Apoyo a las Familias.

Se ofrecerá a través de:

- Apoyo y Asesoramiento individualizado con cada familia de cada usuario.
- Programas grupales de "Escuela de Familias" en los que se ofrece información, psicoeducación y formación en estrategias prácticas de manejo, comunicación y solución de problemas. Su objetivo es enseñarles los conocimientos y habilidades necesarias para entender la problemática de la enfermedad mental, mejorar la convivencia y apoyar positivamente el proceso de rehabilitación de su familiar enfermo mental crónico.
- Apoyo al desarrollo de grupos de autoayuda y asociaciones de familiares.

¿Cómo se accede a los CRPS?

Para acceder a los CRPS los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los CRPS?

Los CRPS funcionan en régimen de atención diurna en jornada partida de mañana y tarde. Los usuarios asistirán al CRPS en función de sus objetivos y necesidades de acuerdo a su plan individualizado de rehabilitación. Asimismo la duración de la estancia será variable ajustada a las necesidades de cada caso.

¿Con qué Personal cuentan los CRPS?

Con un equipo multiprofesional específico compuesto por: un director, psicólogos, trabajador social, terapeuta ocupacional, educadores y auxiliar administrativo.

CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL (CD).

¿Qué son los Centros de Día de soporte social (CD)?

El Centro de Día de soporte social (CD) es un recurso comunitario de apoyo a la mejora del funcionamiento y soporte social dirigido a las personas con enfermedad mental severa con mayores dificultades de funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento o dependencia.

En los Centros de Día se ofrecerán tanto programas de mejora de la autonomía personal y social como un abanico de actividades de día de apoyo y soporte social (culturales, sociales, deportivas, ocupacionales, de ocio, etc.) para facilitar la estructuración de la vida cotidiana y ofrecer el soporte social que los usuarios puedan necesitar.

Su capacidad de atención se sitúa entre 20/30 usuarios.

Los CD trabajan en estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental encargados de la atención

TRUJILLO FORMACIÓN

psiquiátrica y seguimiento de estas personas, así como con los CRPS, y también con los Servicios Sociales Generales y con los recursos sociocomunitarios normalizados para favorecer la integración de los usuarios atendidos.

¿A qué población se dirigen los CD?

A las personas con enfermedades mentales graves y persistentes (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos paranoides, otras psicosis, etc) que presentan mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo con mayores dificultades de funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, dependencia y aislamiento por lo que necesitan una apoyo específico y una estructuración de su vida cotidiana para alcanzar un mínimo de autonomía y apoyar su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Aumentar el nivel de autonomía e integración social.

- Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad.

- Desarrollo y potenciación de habilidades sociales básicas.

- Mantener o conseguir un nivel mínimo de autocuidados y autonomía.

- Incremento de las redes sociales.

- Fomentar las actividades de ocio y tiempo libre.

- Estructuración de la vida cotidiana del paciente

- Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia, Servicios Sociales Generales y otros recursos sociocomunitarios para favorecer y articular una atención integral que posibilite procesos de mantenimiento y apoyo comunitario ajustados a las necesidades de cada usuario.

¿Qué Actividades realizan los CD?

- Mejora del Funcionamiento Psicosocial: Se desarrollará con cada usuario un proceso individualizado de intervención encaminado a facilitar la recuperación o adquisición del conjunto de capacidades y habilidades personales y sociales que le permitan un funcionamiento los más autónomo y normalizado posible en la comunidad, apoyando su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de calidad de vida, fomentando el desempeño de roles sociales normalizados y su progresiva integración social en su entorno socio-comunitario.

- Actividades de día de apoyo y soporte social: Como complemento al proceso de mejora del funcionamiento psicosocial y apoyo a la integración social, en el Centro de Día, se organizarán y promoverán un abanico de actividades de día de apoyo y soporte social (culturales, sociales, deportivas, ocupacionales, de ocio, etc.) para facilitar la estructuración de la vida cotidiana y ofrecer el soporte social que los usuarios puedan necesitar, especialmente con aquellos con mayores dificultades de funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento y marginación. Estas actividades se desarrollarán tanto dentro como fuera del centro fomentando el uso de recursos socio-comunitarios.

- Seguimiento y apoyo comunitario: Asimismo se ofrecerá el apoyo, soporte comunitario y seguimiento necesario en cada caso para asegurar el mantenimiento del nivel de funcionamiento psicosocial y de integración alcanzado y evitar, en la medida de lo posible, procesos de deterioro, aislamiento o marginación especialmente de aquellos usuarios con mayores niveles de déficit o deterioros psicosociales o de dificultades de integración comunitaria. Asimismo en esta línea, se optimizará, lo máximo posible, la utilización de recursos socio-comunitarios normalizados. Para ello, desde el Centro de Día se trabajará en estrecha colaboración y coordinación con los Servicios de Salud Mental de referencia, así como con los Servicios Sociales Generales y cuantos otros recursos comunitarios sean relevantes.

- Apoyo a las Familias: Desde el Centro de Día se ofrecerá a las familias información, formación,

TRUJILLO FORMACIÓN

asesoramiento y apoyo a fin de mejorar su capacidad de manejo y convivencia con su familiar con enfermedad mental y contribuir a mejorar la situación y calidad de vida de la propia familia. Asimismo se buscará implicar a la familia como un recurso activo en el proceso de rehabilitación e integración de la persona familiar enferma mental. Además desde el Centro se fomentará y apoyará el desarrollo de grupos de autoayuda y asociaciones entre los familiares y enfermos mentales crónicos.

Asimismo en el Centro de Día se podrá ofrecer un **Servicio complementario de comidas** para aquellos usuarios que lo puedan necesitar por razones sociales, de lejanía de su domicilio y de asistencia e implicación en las actividades de apoyo y soporte social.

¿Cómo se accede a los CD? Para acceder a los CD los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los CD?

Los Centros de Día funcionan en régimen de atención diurna en jornada partida de mañana y tarde. Los usuarios asistirán al CD el tiempo necesario (toda la mañana o todo el día) en función de sus objetivos y necesidades de acuerdo a su plan individualizado. Asimismo la duración de la estancia será estable y en todo caso la que sea precisa en relación con las necesidades de soporte social e integración comunitaria de cada caso.

¿Con qué Personal cuentan los CD? Con un equipo multiprofesional específico compuesto por: psicólogo, terapeuta ocupacional, y educadores.

CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL (CRL).

¿Qué son los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL)?

Los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) son un recurso específico, de servicios sociales especializados, destinado a las personas con enfermedad mental severa para ayudarles a recuperar o adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su integración y mantenimiento en el mismo.

Su capacidad de atención se sitúa en torno a 50 usuarios.

Los CRL trabajan en estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental encargados de la atención psiquiátrica y seguimiento de estas personas, así como con los Centros de Rehabilitación Psicosocial. Asimismo trabajarán en estrecha relación con el conjunto de recursos de formación y empleo a fin de facilitar el proceso de integración laboral de los usuarios.

¿A qué población se dirigen los CRL?

A las personas con enfermedades mentales severas y persistentes (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos paranoides, otras psicosis, etc.) que teniendo un mínimo nivel de autonomía personal y social, necesitan un apoyo específico y estructurado que les prepare y apoye para su inserción laboral.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de conocimientos, hábitos básicos de trabajo y habilidades sociolaborales necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral.

- Propiciar y apoyar su inserción en el mercado laboral muy especialmente en el normalizado (empresas, autoempleo) o en su caso en empleo protegido (Centros Especiales de Empleo).

- Ofrecer el seguimiento y apoyo que cada persona necesite para asegurar su mantenimiento en el mundo laboral, del modo más autónomo y normalizado que sea posible en cada caso.

- Articular y organizar el contacto con los recursos de formación laboral y con el mercado laboral para

TRUJILLO FORMACIÓN

facilitar los procesos de rehabilitación e inserción laboral.

- Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar las oportunidades de integración laboral de este colectivo.

¿Qué Actividades realizan los CRL?

Programas individualizados de Rehabilitación Laboral.

Encaminados a preparar y capacitar a cada usuario para estar en condiciones de manejar y enfrentarse a las demandas y exigencias que supone la búsqueda, acceso y mantenimiento de un empleo en el mercado laboral.

Incluyen y ofrecen un amplio abanico de actividades:

- Evaluación funcional vocacional-laboral.

- Orientación vocacional.

- Diseño y programación del plan individualizado de rehabilitación profesionallaboral.

- Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo.

- Entrenamiento en habilidades de ajuste laboral.

- Apoyo a la Formación profesional.

- Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo.

- Apoyo a la inserción laboral y seguimiento.

Dichas actividades se ajustarán a las necesidades de cada caso de acuerdo a lo establecido en su plan individualizado de rehabilitación laboral.

Apoyo a la Integración laboral y seguimiento.

Una vez finalizado el proceso específico de rehabilitación laboral, y/o alcanzados los principales objetivos establecidos en el plan individualizado de cada usuario, los CRL desarrollarán un proceso flexible y específico de apoyo a la integración laboral, especialmente en el mercado laboral ordinario. Así como un seguimiento y apoyo que asegure el mantenimiento en el puesto de trabajo obtenido.

Contacto y coordinación.

- Con los recursos de formación laboral existentes (IMAF, IMEFE, Escuelas-Taller, Casas de Oficios...) para favorecer y apoyar el acceso de los usuarios a los mismos de cara a mejorar su cualificación laboral.

- Con el tejido laboral para facilitar y fomentar la contratación laboral de este colectivo.

¿Cómo se accede a los CRL?

Para acceder a los CRL los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los CRL?

Los CRL funcionan en régimen de atención diurna, con un horario de lunes a viernes en jornada partida de mañana y tarde. Los usuarios asistirán al CRL en función de sus objetivos y necesidades de acuerdo a su plan individualizado de rehabilitación. Asimismo la duración de la estancia será variable ajustada a las necesidades de cada caso.

¿Con qué Personal cuentan los CRL?

Con un equipo multiprofesional específico compuesto por: un director, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de apoyo a la inserción laboral, preparador laboral, maestros de taller y auxiliar administrativo.

TRUJILLO FORMACIÓN

EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO (EASC).

¿Qué son los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC)?

Los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) constituyen un recurso que viene a complementar la Red de Centros de Atención Social a personas con enfermedad mental severa y persistente que se configuran como un equipo social multiprofesional cuyas funciones básicas son:

En primer lugar ofrecer atención social domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando situación de riesgo de marginación o de institucionalización y, en segundo lugar con aquellos usuarios que sea necesario, ofrecer acompañamiento y apoyo para mejorar el enganche y vinculación con la red de recursos de salud mental y de servicios sociales y de apoyo en su propio entorno a fin de mejorar su situación y calidad de vida y ofrecer apoyo a sus familias.

Cada EASC se estima tendrá capacidad para ofrecer esta atención y apoyo domiciliario a unos 30 usuarios. Los EASC trabajarán integrados en los programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental de cada distrito desde una lógica de estrecha integración, coordinación, complementariedad y trabajo en red

¿A qué población se dirigen los EASC?

A las personas con enfermedades mentales graves y duraderas con dificultades de integración en recursos socio-comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar; que necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones de abandono y marginación y sobre todo ayudarles en la medida de lo posible a mantenerse en adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno familiar y social.

Y aquellos pacientes con enfermedad mental severa o grave de curso persistente detectados por los servicios de Salud Mental pero que presentan importantes dificultades para mantenerse en contacto o en seguimiento regular o continuado en los Servicios de Salud Mental, con un nivel importante de deterioro psicosocial y/o gran aislamiento social. En estos casos el EASC servirá de apoyo y complemento para fomentar y facilitar la vinculación regular y adecuada del paciente con el SSM y con otros recursos específicos de atención social y con otros recursos comunitarios que faciliten la mejora de su situación, calidad de vida y posibilidades de integración comunitaria.

¿Cuáles son sus Objetivos?

Los EASC se organizan para servir a los siguientes objetivos generales:

- Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar en las mejores condiciones posibles.

- Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo comunitario que faciliten la mejora de la situación y calidad de vida de los usuarios en su propio domicilio y en su entorno.

- Evitar situaciones de marginalización y abandono.

- Apoyar a la utilización de recursos.

- Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar situaciones de sobrecarga de las familias.

- Colaborar en el acompañamiento social y apoyo para mejorar la vinculación con la red de atención de salud mental y de servicios sociales.

TRUJILLO FORMACIÓN

¿Qué Actividades realizan los EASC?

Atención Social Domiciliaria y Apoyo Social Comunitario:

Se desarrollará con cada usuario en coordinación y complementariedad con el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del SSM de referencia, un proceso individualizado de atención y apoyo social en su propio domicilio y en su entorno familiar y social encaminado a apoyar su mantenimiento en su domicilio y en su entorno familiar y/o social en las mejores condiciones posibles de calidad de vida, promoviendo su progresiva integración social en su entorno socio-comunitario.

La intervención en este área, por tanto, deberá cubrir todos aquellos aspectos del funcionamiento psicosocial y social que ayuden al usuario a mejorar su autonomía personal y a facilitar que se pueda mantener en su domicilio y en su entorno en las mejores condiciones posibles, evitando procesos de deterioro o marginalización. En este sentido los profesionales del EASC, trabajarán con cada usuario en su domicilio y en su entorno adaptándose específicamente a las necesidades de cada usuario y a los objetivos establecidos.

Acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red:

Asimismo con aquellos usuarios que sea necesario se ofrecerá el apoyo y acompañamiento preciso en cada caso para promover y facilitar la adecuada vinculación y contacto con su Servicio de Salud Mental de referencia y con la red de recursos específicos de atención social a este colectivo existentes en la zona y otros recursos comunitarios que resulten necesarios para que dichos usuarios puedan beneficiarse de una adecuada atención integral y continuada.

¿Cómo se accede a los EASC?

Para acceder a los EASC los usuarios habrán de ser derivados desde el Servicios de Salud Mental del distrito de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento. EL EASC trabajara de un modo integrado y coordinado con el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del Servicio de Salud Mental del distrito de referencia.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los EASC?

El funcionamiento de los EASC será de lunes a viernes, excepto festivos, en jornada partida, con, como mínimo, un horario de atención de 9 a 18 h.

Los usuarios recibirán la atención y apoyo desde cada EASC el tiempo necesario en función de sus objetivos y necesidades de atención y apoyo de acuerdo a su plan individualizado y a lo establecido en la coordinación con el programa de continuidad de cuidados del SSM de referencia. La intensidad de la atención prestada podrá variar en función de las necesidades de apoyo y del momento del proceso de atención. Así habrá usuarios que necesiten visitas y apoyos en el domicilio todos los días, otros varias veces a la semana y otros de un modo más esporádico

¿Con qué Personal cuentan los EASC?

Cada EASC está formado un equipo multiprofesional específico compuesto por: psicólogo, trabajador social y dos educadores.

RESIDENCIAS.

¿Qué son las Residencias (R)?

Las Residencias (R) son un recurso residencial comunitario dirigido específicamente a personas con enfermedad mental grave y duradera con necesidades de apoyo residencial.

TRUJILLO FORMACIÓN

Su capacidad de atención se sitúa entre 20/30 usuarios.

Proporcionan con carácter temporal (estancia corta o transitoria) o indefinido: alojamiento, manutención, cuidado y soporte así como apoyo a la mejora de la autonomía personal y social. Ofrecen supervisión y apoyo durante las 24 h del día, en un ambiente de convivencia los más familiar y normalizado posible.

¿A qué población se dirigen las Residencias?

A las personas con enfermedad mental severa y persistente (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos delirantes, otras psicosis, etc) que necesitan un apoyo residencial específico y supervisado, de mayor o menor duración, debido a:

- Ausencia de apoyo familiar o incapacidad de la familia para su atención y cuidado.

- Problemas de autonomía y funcionamiento psicosocial que les impidan o dificulten para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y soporte.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y soporte.

- Favorecer la mejora de la autonomía personal y social de los usuarios y su progresiva integración social.

- Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de normalización y calidad de vida.

- Evitar situaciones de abandono, marginación y/o institucionalización.

¿Qué Tipos de Estancias ofrecen las Residencias?

La organización está planteada de un modo flexible y polivalente para atender las diferentes necesidades y objetivos planteados por la población con enfermedad mental severa. Así sus plazas se distribuyen para ofrecer diferentes tipos de estancias:

- **Estancias Cortas** (de un fin de semana a un mes aprox.) Principalmente como recurso de apoyo a las familias ofreciendo momentos de "descanso familiar", cubriendo situaciones de urgencia familiar (enfermedades, etc.) o para aliviar situaciones de sobrecarga y tensión. Entre un 10/20 % de las plazas.
- **Estancias Transitorias** (de un mes a un año aprox.) Como periodo de preparación y apoyo que permita una adecuada transición desde el Hospital a la Comunidad, prepare la reinserción en el entorno familiar o para opciones de vida y alojamiento más autónomos e independientes. Entre un 30/40 % de las plazas.
- **Estancias Indefinidas** (más de un año) Para personas que por su deterioro psicosocial y su carencia de apoyo familiar y social, necesiten una atención residencial de mayor duración ofreciendo una calidad de vida digna y evitando situaciones de marginación y/o institucionalización. Entre un 40/50% de las plazas.

¿Qué Servicios prestan las Residencias?

- Alojamiento, manutención y cuidado.
- Apoyo y supervisión durante las 24 horas.
- Una atención personalizada ajustada a las características, necesidades y objetivos de cada usuario.
- Un funcionamiento interno lo más parecido a un hogar familiar, fomentando la participación de los residentes en su organización y en el desarrollo de las tareas domésticas.
- Una atención psicosocial orientada a promover la rehabilitación e integración social, incluyendo actividades de autocuidado, actividades de la vida diaria, psicoeducación, relaciones sociales, integración comunitaria y ocio y tiempo libre.

TRUJILLO FORMACIÓN

- Una estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental de referencia, con Sociales Generales, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Día y demás centros de atención social especializada así como cuantos otros recursos sociocomunitarios sean necesarios para asegurar una atención integral a los usuarios.

¿Cómo se accede a las Residencias?

Para acceder a una Residencia los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de las Residencias?

Las Residencias funcionan en régimen de atención residencial abierto y flexible y con un ambiente lo más familiar y normalizado posible, fomentado además la implicación y participación activa de los usuarios. La duración de la estancia será variable, ajustada a las necesidades de cada caso. La estancia es voluntaria.

¿Con qué Personal cuentan las Residencias?

Con un equipo multiprofesional específico compuesto básicamente por: un director, psicólogo, terapeuta ocupacional, monitores ó educadores en turnos de mañana, tarde y noche asegurando 24 h. al día durante toda la semana, auxiliar administrativo, y personal de cocina y limpieza.

PISOS SUPERVISADOS.

¿Qué son los Pisos Supervisados (Ps)?

Los Pisos Supervisados son un recurso de alojamiento comunitario organizado en pisos o viviendas normales en los que pueden residir entre 3 y 5 personas con enfermedades mentales severas y persistentes.

Ofrecen una alternativa estable y normalizada de alojamiento y soporte, completada con una supervisión y apoyo flexible ajustada las diferentes necesidades de cada piso y de sus usuarios.

¿A qué población se dirigen?

A las personas con enfermedades mentales severas y persistentes (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos delirantes, otras psicosis, etc) que tienen un nivel mínimo de autonomía personal y social pero necesitan una apoyo residencial debido a:

- Ausencia de apoyo familiar o incapacidad o sobrecarga de la familia para su atención y cuidado.

- Problemas de autonomía y funcionamiento psicosocial que les impidan o dificulten para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y soporte, y tienen dificultades para mantenerse solos en una vivienda.

- No requieren una supervisión de 24 horas como la que ofrecen las MiniResidencias, con un apoyo flexible pueden adaptarse, convivir y funcionar adecuadamente en los Pisos.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte lo más normalizado posible que facilite el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de autonomía y calidad de vida.

- Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria de cada usuario.

- Evitar situaciones de abandono y marginación o procesos de cronificación y deterioro de usuarios sin apoyo familiar o social.

¿Cuáles son sus principales características?

TRUJILLO FORMACIÓN

- Un espacio normalizado de alojamiento y convivencia.
- Un contexto para favorecer la rehabilitación y la integración comunitaria de los usuarios.
- Con un sistema de apoyo y supervisión flexible que asegure respuestas ágiles y rápidas a las necesidades de cada piso y de cada uno de sus usuarios.
- Una participación activa y autónoma de los residentes en su organización y en el desarrollo de las tareas domésticas.
- Una atención y apoyo psicosocial orientada a mejorar la autonomía e independencia del usuario y promover el desempeño de roles sociales normalizados que faciliten su progresiva integración comunitaria.
- Una estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental de referencia, con Residencias, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Servicios Sociales Generales y cuantos otros recursos sociocomunitarios sean necesarios para asegurar una atención integral a los usuarios.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los Pisos Supervisados?

Los Pisos funcionan con un ambiente lo más parecido a un hogar familiar. Los usuarios se encargarán, con el apoyo oportuno, de todas las tareas domésticas y de organización interna. Los gastos generales y de mantenimiento de los Pisos correrán a cargo de la Comunidad de Madrid, debiendo los usuarios asumir los gastos de manutención y otros gastos de funcionamiento cotidiano.

La duración de la estancia será variable, ajustada a las necesidades de cada caso. La estancia es voluntaria.

¿Cómo se accede?

Para acceder a un Piso Supervisado, los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento

¿Con qué Personal cuentan?

Con un equipo específico de monitores/educadores para ofrecer supervisión flexible y ajustada a la necesidades de cada piso ofreciendo el apoyo oportuno tanto en el funcionamiento doméstico y convivencia dentro del piso como en la adaptación e integración en el entorno comunitario.

Asimismo se cuenta con el apoyo y coordinación de los Servicios de Salud Mental de referencia y de las Residencias y demás recursos de atención social del presente Plan.

Los pisos supervisados funcionan en estrecha vinculación organizativa y funcionalmente con las Residencias a las que en su mayoría están vinculados.

PLAZAS SUPERVISADAS EN PENSIONES.

¿Qué son las Plazas supervisadas en Pensiones (Pc)?

Las Plazas supervisadas en Pensiones son una alternativa de alojamiento comunitaria organizada a través del acuerdo con Pensiones de Huéspedes para utilizar algunas de sus plazas para personas con enfermedades mentales severas y persistentes.

Ofrecen una alternativa flexible y normalizada de alojamiento y cobertura de necesidades básicas, completada con una supervisión ajustada las diferentes necesidades de cada usuario.

¿A qué población se dirigen?

A las personas con enfermedad mentales graves y persistente (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos delirantes, otras psicosis, etc) que tienen un buen nivel de autonomía personal y social pero

TRUJILLO FORMACIÓN

necesitan un apoyo residencial debido a:

- Ausencia de apoyo familiar o incapacidad o sobrecarga de la familia para su atención y cuidado.

- Son fundamentalmente personas solas con escasos recursos económicos y estilos de vida bastante independientes.

- No requieren una supervisión de 24 horas como la que ofrecen las MiniResidencias, ni necesitan o se adecuan a la convivencia en Pisos supervisados.

¿Cuáles son sus Objetivos?

- Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de autonomía y calidad de vida.

- Facilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria de cada usuario.

- Evitar situaciones de abandono y marginación.

¿Qué Servicios se prestan en las Plazas Supervisadas en Pensiones?

A través de acuerdos con diferentes Pensiones se facilitan un determinado número de plazas con los siguientes servicios básicos:

- Cama en habitación individual y disponibilidad de utilizar los espacios comunes de la pensión.
- Desayuno diario así como disponibilidad de aseo y ducha diaria.
- Lavado, planchado y repaso de la ropa personal una vez por semana, así como cambio de ropa de cama.
- Con un sistema de apoyo y supervisión flexible desde los Servicios de Salud Mental responsables de cada usuario.

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de las Plazas Supervisadas en Pensiones?

Las plazas supervisadas en Pensiones pretenden ofrecer un alojamiento en un ambiente lo más parecido a un hogar familiar. Los usuarios se integrarán, con el apoyo oportuno, en la vida cotidiana de la Pensión. Los Servicios de Salud Mental de referencia, con el apoyo de las Residencias y demás recursos de atención social del presente Plan, ofrecerán el apoyo y supervisión necesaria tanto a los responsables de la Pensión como a los usuarios para asegurar su adecuada adaptación y promover su rehabilitación e integración comunitaria.

Las Pensiones se gestionan a través de las Residencias a las que están vinculadas. Los costes de la plaza correrán a cargo de la Comunidad de Madrid en el marco del contrato de gestión de la Residencia de la que dependan las distintas Plazas en Pensiones, debiendo los usuarios asumir los gastos de su manutención y otros gastos personales de funcionamiento cotidiano. La duración de la estancia será variable, ajustada a las necesidades de cada caso.

La estancia es voluntaria.

¿Cómo se accede?

Para acceder a una plaza concertada en una de la Pensiones, los usuarios habrán de ser derivados desde los Servicios de Salud Mental de referencia que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.

¿Con qué Personal cuentan?

La supervisión se realiza con monitores/educadores ofreciendo el apoyo oportuno tanto en el funcionamiento y convivencia dentro de la Pensión como en la adaptación e integración en el entorno comunitario.

Asimismo se trabaja con la coordinación y apoyo desde los Servicios de Salud Mental de referencia con la colaboración de la Residencia a la que están vinculadas las plazas de Pensiones y con el apoyo de los demás

TRUJILLO FORMACIÓN

recursos de atención social.

SERVICIO DE APOYO A LA REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN.

¿Qué es el Servicio de atención y apoyo a la reinserción social personas con enfermedad mental crónica en situación de marginación y exclusión?

Se trata de una iniciativa que viene desarrollando estrategias específicas de intervención y apoyo para mejorar la atención social y favorecer la progresiva reinserción social de personas con enfermedades mentales severas que se encuentran en una situación de marginación sin hogar y por tanto sufren una grave exclusión social.

Este Servicio de atención social y apoyo a la reinserción tiene unas características específicas y diferenciales que se resumen en:

- Un estilo de "búsqueda" acercándose a la población allí donde se encuentra, sea en recursos de atención a personas sin hogar o en la calle.

- Un estilo de atención muy flexible ajustado a las características y peculiaridades de este colectivo, ofreciendo el apoyo necesario en cada caso y buscando siempre la progresiva implicación y responsabilización de cada persona atendida en su proceso de reinserción social y en el control de sus propias vidas.

- Un proceso de atención individualizado ajustado a la especificidad y momento concreto de cada persona y siempre orientado a promover su reinserción social del modo más autónomo y normalizado posible.

¿A quién se dirige?

Específicamente a aquellas personas con problemas de enfermedad mental severa en situación de exclusión y/o marginación sin hogar para mejorar su atención social y promover su progresiva reinserción social

¿Cuáles son sus Objetivos Generales?

- Acercarse a este colectivo y mejorar el conocimiento sobre su problemática y necesidades.

- Promover la mejora de su situación y calidad de vida apoyando su acceso y vinculación con los servicios comunitarios pertinentes (Centros de Salud Mental, Servicios Sociales Generales, Recursos socio-comunitarios, etc.).

- Favorecer la recuperación de la mayor autonomía personal y social que sea posible en cada caso.

- Posibilitar y apoyar su progresiva reinserción social y mantenimiento normalizado en la comunidad.

¿Qué Acciones desarrolla?

<u>Programas individualizados de mejora del funcionamiento psicosocial y apoyo comunitario.</u>

Con aquellos atendidos en el Centro de Acogida municipal se les ofrecerán programas y actividades con el fin de:

- Ayudarles a recuperar el conjunto de habilidades y capacidades necesarias para manejarse en la comunidad con la mayor autonomía personal y social.

- Apoyar y potenciar su vinculación con los servicios comunitarios existentes y pertinentes para su proceso de atención, rehabilitación y reinserción (Servicios de Salud Mental, Servicios Sociales Generales, Centros de Atención Social específicos, Otros Recursos Sociocomunitarios, etc.).

- Preparar, apoyar y facilitar su progresiva reinserción social normalizada.

TRUJILLO FORMACIÓN

Programas de Apoyo social y de acompañamiento en Itinerarios de Reinserción social.

El equipo del Proyecto ofrecerá también de un modo individualizado y flexible programas de apoyo social y de acompañamiento y seguimiento en itinerarios de reinserción con otros usuarios personas sin hogar con enfermedad mental que malviven en las calles y/o utilizan recursos básicos de la red de atención a Personas sin Hogar. Se trata de colaborar en la mejora de la situación personal y social facilitando y fomentando su enganche a la red de atención y apoyar su vinculación a los distintos recursos y programas que necesite. Así como ofrecer de un modo individualizado y flexible el apoyo personal, acompañamiento y seguimiento que en cada caso sea necesario para favorecer el desarrollo de los itinerarios de reinserción planteados con cada uno de los usuarios

En esta línea trabajaran con aquellos usuarios de estas características que están en contacto y tratamiento con el equipo de atención psiquiátrica de calle dependiente del Servicio Madrileño de Salud (Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental).

Alternativas Residenciales Comunitarias.

Se cuenta, en estos momentos, con 5 pisos (20 plazas) que funcionan como alternativas de alojamiento y apoyo normalizadas que cuentan con una supervisión específica, flexible y continuada por parte del equipo del Servicio.

Asimismo se viene apoyando también a los usuarios para la utilización y mantenimiento en otras alternativas de alojamiento (residencias, pensiones, pisos compartidos, reinserción familiar, etc.) que favorezcan su proceso individualizado de reinserción social.

¿Con qué Personal cuenta el Servicio?

Se cuenta con un equipo multiprofesional específico formado por un Coordinador, Psicólogos, Trabajador social y Educadores, que trabajan de un modo flexible y coordinado en el desarrollo de las diferentes acciones que componen el Servicio. Este equipo trabajara en estrecha coordinación y apoyo con el Equipo de Atención Psiquiátrico de Calle así como también en colaboración con otras entidades y recursos de atención a personas sin hogar, y con la red de centros de atención social a personas con enfermedad mental crónica de la Comunidad de Madrid.

3.- ASPECTOS LEGALES EN LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

La **Constitución** Española reconoce en su **artículo 43** el **derecho a la protección de la salud.** En su apartado 2 se incluye un mandato a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Sin embargo, a pesar de ser claro el texto de la ley fundamental, el concepto de protección no se ha interpretado de forma adecuada y nuestro sistema sanitario se ha dirigido única y fundamentalmente a ofertar servicios sanitarios frente a las enfermedades. Igual que en otras áreas de la sanidad, el campo de la prevención ha estado totalmente abandonado en la salud mental.

Asimismo, en el **artículo 49** de la Constitución se contempla un nuevo mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política que garantice la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. El desarrollo del mandato contenido en el artículo 49 se centra, pues, en la batería de políticas asistenciales a las personas con diversidad funcional adoptadas y normadas por los poderes públicos; políticas que se proyectan en una pluralidad de ámbitos diferenciados (laborales, culturales, vivienda, educación, ocio, deportes, etc.). Esto encuentra su base en la asunción de que la diversidad funcional impide o dificulta su inserción normalizada en las relaciones habituales de la vida social.

TRUJILLO FORMACIÓN

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 18.8, atribuye a las Administraciones Públicas el deber de promover y mejorar la salud mental. Además, en su artículo 20, la Ley General de Sanidad incorpora principios rectores como la plena integración de la salud mental en el sistema sanitario general, la inclusión de la salud mental en el ámbito comunitario y la atención integral y coordinada.

Con posterioridad, la **Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud**, en sus artículos 12 y 13, incluyó la atención a la salud mental como parte integrante de las prestaciones de atención primaria y atención especializada, desarrolladas y concretadas en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización

Uno de los principales problemas que presenta la atención a la salud mental en nuestro país es la inaccesibilidad real y percibida que trae causa de la ausencia de profesionales suficientes en el sistema sanitario público. Se genera así una desigualdad por motivos económicos en el acceso a la atención a la salud mental, ya que las personas con más recursos tienen la capacidad de acudir a los servicios que ofrece el sector privado. Por ello, la presente ley establece nuevas garantías de tiempo y ratios de profesionales en aras de facilitar y extender el acceso a la atención pública a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud.

3.1.- ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO PENAL.

La problemática del enfermo mental en el ámbito penal abarca aspectos tales como su grado de responsabilidad en los supuestos de comisión de delitos, sanciones generales y/o medidas que les pueden ser aplicadas, lugar de cumplimiento de las mismas, etc... Iremos analizando estas situaciones para observar la consideración que el enfermo mental recibe en el vigente Código Penal español.

3.1.1.- IMPUTABILIDAD / INIMPUTABILIDAD.

Para poder reprochar a una persona el haber realizado una conducta dañina o peligrosa para bienes o derechos fundamentales (es decir, tipificada en el Código Penal) será preciso que la persona tenga capacidad para comprender que está realizando algo prohibido y que además tenga capacidad de conducir y controlar su comportamiento adecuándolo y conformándolo a ese conocimiento.

Esa capacidad de comprender lo injusto del hecho (su oposición al Derecho) y esa capacidad de dirigir la acción conforme a dicho entendimiento constituye lo que se denomina **imputabilidad**. Recordando que para poder hablar de la ausencia de esa imputabilidad, esto es, de la **inimputabilidad**, será preciso que el sujeto que ha realizado el comportamiento humano antijurídico sea incapaz de comprender el carácter antijurídico del mismo o de acomodar su conducta a dicho conocimiento.

TRUJILLO FORMACIÓN

Conceptualmente la enfermedad mental supondría una **causa de inimputabilidad** [1] ya que al enajenado no será posible reprocharle un acto que él, efectivamente, ha cometido, pero con una incapacidad para comprender lo injusto de su acción o con una incapacidad para dirigir su actividad. En los casos en los que los enfermos mentales realizan o cometen actos delictivos el derecho Penal reacciona, pero lo hace con una respuesta (penalizadora) de menor intensidad que la ejercitada frente a un sujeto imputable.

La enajenación mental puede ser considerada a efectos penales de tres maneras:

a) Como **eximente completa**, quedando exento de responsabilidad criminal y sin posibilidad de imponérsele una pena, aunque sí exista la facultad del Tribunal para decretar el internamiento o sustituirlo por otro tipo de medidas.

b) Como **eximente incompleta**, enjuiciando a la persona como merecedora de sanción penal pero de un modo atenuado respecto a personas que no tuvieren ese grado de trastorno mental. La atenuación consistiría en la posibilidad de rebajar la pena en uno o dos grados y también la de sustituirla por alguna de las medidas previstas en el Código.

c) Como simple **atenuante** analógica, en cuyo caso los Tribunales impondrían la pena en su grado mínimo.

3.2.- EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO.

Los ingresos hospitalarios en cualquier área de la Medicina vienen clasificados de acuerdo a diferentes parámetros. En el campo de la psiquiatría y debido a la especial vulnerabilidad del aparato psíquico se han tomado ciertas medidas específicas que tienden a regular el ingreso del enfermo mental.

- El primer tipo de ingreso contemplado es el del **Ingreso Voluntario**. Este ingreso supone la existencia de un libre contrato y cuenta con el consentimiento del paciente. El paciente firma una solicitud de ingreso voluntario. Este tipo de ingresos no suele dar lugar a conflictos, siendo el más habitual en la práctica psiquiátrica cotidiana. En ellos será responsabilidad del sistema sanitario establecer las cautelas oportunas para garantizar que la voluntariedad del enfermo se respete desde su ingreso hasta su alta hospitalaria.

1

Artículo 20 del Código Penal.
Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

TRUJILLO FORMACIÓN

- El segundo supuesto contempla a los **Ingresos Involuntarios**. Estos, a su vez, se subdividen en "Ordinarios" o "De Urgencia". En ambos casos se delimita la libertad del enfermo ya que se actúa contra su voluntad por lo que la Ley pone en marcha el sistema de garantías y que establece, fundamentalmente, que para llevar a cabo el ingreso hospitalario será necesaria la Autorización Judicial.

En el art. 763 de la **Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2.000, de 7 de enero,** se va a regular el **internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.**

1. **El internamiento, por razón de trastorno psíquico**, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, **requerirá autorización judicial**, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, **dentro del plazo de veinticuatro horas**, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al **tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento**. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

2. El **internamiento de menores** se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente

TRUJILLO FORMACIÓN

Los últimos acuerdos en salud mental se han realizado en la **conferencia «Democracia y Salud Mental Comunitaria»** que tuvo lugar en el Centro Colaborador de la **OMS en Trieste, Italia, en junio de 2018**. Allí, expertos y expertas de más de treinta países del campo de la salud mental discutieron y rechazaron el Proyecto de Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (más conocido como Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o Convenio de Oviedo), tal como la propuso el Comité de Bioética del Consejo de Europa sobre la protección de los Derechos Humanos y dignidad de las personas con trastornos mentales respecto al internamiento y tratamiento involuntario por apartarse de las normas emitidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

También hay que añadir que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) desaconseja este proyecto de Protocolo. A este posicionamiento contrario se suma un gran número de organizaciones europeas y órganos de derechos humanos de alto nivel, reconociendo que el internamiento y el tratamiento involuntario suponen una amplia violación de los derechos humanos, incluido el uso de la reclusión y restricción que viola los derechos humanos de las personas con discapacidades psicológicas y sociales.

4.- PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Y FAMILIARES, HUMANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL.

En España, a la luz de las recomendaciones de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, creada en 1983, la legislación y las políticas públicas en el ámbito de la salud mental han experimentado avances significativos, pero desiguales e insuficientes, hacia la construcción de un modelo comunitario y universal de atención y la integración de las personas con trastornos de salud mental.

Con anterioridad a la «Reforma Psiquiátrica» de los años ochenta, que da paso a la desinstitucionalización, la práctica clínica extendida para solucionar los problemas de salud mental y cuidar el bienestar social era la reclusión en instituciones de la persona diagnosticada, alejándola de la comunidad, colocándola en un contexto de total exclusión social y asumiendo su cronicidad.

A pesar del cambio de orientación que supuso la «Reforma Psiquiátrica», las soluciones a los problemas de salud mental se han dirigido de manera prácticamente exclusiva a disminuir los diferentes tipos de sintomatología, fundamentalmente a través de tratamientos farmacológicos, relegando la promoción y la inclusión social y comunitaria a un segundo plano.

En las últimas décadas, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las diferentes comunidades autónomas han elaborado estrategias y planes de salud mental. Si bien su implementación ha aportado diversos elementos enriquecedores, los servicios ofrecidos continúan siendo insuficientes, sin que se garanticen plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito de la atención brindada a las personas por motivos de salud mental.

Los problemas de salud mental representan el área que ha recibido un menor nivel de resolución en nuestro Sistema Nacional de Salud. Contamos con una atención fragmentada, insuficiente, biologicista y centrada en la reducción sintomatológica. Por otro lado, o bien carecemos de datos epidemiológicos, o bien estos son incompletos, no desagregados y de poca utilidad para valorar la incidencia, la prevalencia y el impacto de los trastornos mentales.

TRUJILLO FORMACIÓN

El **estigma** aún presente en torno a la cuestión de la salud mental provoca, en primer lugar, que los datos epidemiológicos sean incompletos, lo que dificulta una valoración certera de la incidencia, la prevalencia y el impacto de los trastornos mentales. Además, esa estigmatización provoca que la persona que sufre no solicite ayuda a tiempo y en el lugar adecuado.

El **Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, 2.022-2.024** desarrolla en su **Línea Estratégica 9 la participación de los usuarios y familiares, humanización y lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental.**

La Organización de Naciones Unidas, en la Declaración de Principios para la protección de los enfermos mentales y para la mejora de la atención de la salud mental *(ONU; 1991),* establece que «Todas las personas que padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana». También dice que «No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental. Por discriminación se entenderá cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo resultado sea impedir o menoscabar el disfrute de los derechos en pie de igualdad» *(OMS, 2012)*.

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el período 2022-2026 dice "La desinformación y la falta de toma de conciencia sobre la salud mental producen que en muchas ocasiones la sociedad discrimine, rechace o estigmatice a las personas con problemas de salud mental" y más adelante "Por encima de los síntomas de su problema de salud, muchas veces el estigma y la discriminación son las principales barreras en las actitudes de la población general. Esto dificulta la recuperación y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental".

La Declaración Universal de los Derechos humanos, de 10 de diciembre de 1948, proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, expone que todas las personas tienen todos los derechos y libertades de la Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo que implica también a las personas con enfermedad mental.

Este mismo espíritu sigue la reforma legislativa operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que mostrándose fiel a la Convención Internacional de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad de 2006 que establecía la participación auténtica y significativa de las personas con problemas de salud mental, en todos los aspectos que les conciernen; «Nada sobre nosotros sin nosotros», da un giro radical al tratamiento de la discapacidad contemplando el deber de respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas. La dignidad del paciente es también el principio básico que rige la relación clínica (artículo 2.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), abogando por la humanización de la asistencia sanitaria.

En los Planes de Salud Mental anteriores de la Comunidad de Madrid, Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental 2003 -2008, Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 y Plan Estratégico de Salud Mental 2018-2020 principalmente se recogían los principios de participación, rechazo a la estigmatización, la discriminación y la falta de respeto por los derechos humanos, abogando por la dignidad de las personas que padecen enfermedades. Quedando recogidos los objetivos y actividades que el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019 *(Consejería de Sanidad CAM, 2016)* ya señalaba como vinculantes.

Hay que señalar el freno que ha supuesto la Pandemia de COVID-19 en la humanización sanitaria. La participación de usuarios y familiares en los servicios de salud mental se vio truncado, desapareció la prespecialidad, la cercanía, poniendo de manifiesto mayores retos en materia de humanización, una vez controlada la pandemia.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

Dada la transversalidad de esta línea estratégica y de acuerdo con el análisis de situación se han establecido cuatro ámbitos de acción orientados a alcanzar los siguientes objetivos generales:

1. Avanzar en la humanización y el respeto en la atención a personas con problemas de salud mental.

2. Avanzar en la participación de usuarios y familiares.

3. Avanzar en la lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental.

4. Extremar la atención y humanización de los cuidados a las personas con enfermedad mental especialmente vulnerables y con alto riesgo de exclusión social.

TRUJILLO FORMACIÓN